MÓDULO 1 · FUNDAMENTOS DE MEDICAL AFFAIRS Y SU ROL ESTRATÉGICO

Centrado en el paciente y valor en salud

El "patient centricity" (centrado en el paciente) se usa a menudo como eslogan de marketing, pero tiene una definición precisa y operativa en la industria: una cultura organizativa y un conjunto de prácticas que sitúan de forma consistente al paciente en el centro de la toma de decisiones, respondiendo a necesidades expresadas por los propios pacientes, sin dejar de impulsar resultados de negocio legítimos. Una definición colaborativa ampliamente citada de Patient Engagement for Medicines Development lo describe como "poner al paciente primero en un compromiso abierto y sostenido con el paciente, para lograr con respeto y compasión la mejor experiencia y el mejor resultado para esa persona y su familia". Para Medical Affairs, esto no es una declaración de valores para una diapositiva: cambia qué cuenta como buen trabajo científico.

- Cultura y prácticas que sitúan al paciente en el centro de la decisión
- Responde a necesidades expresadas por los propios pacientes
- No es una declaración de valores — cambia qué cuenta como buen trabajo científico

El cambio que exige el centrado en el paciente es pasar de pensar en "la pastilla" a pensar en "la salud" — las dimensiones física, mental, social y emocional de lo que un paciente realmente experimenta al vivir con una condición y un tratamiento. Un medicamento puede ser eficaz en un endpoint de ensayo y aun así fallar a los pacientes si se administra de una forma que ignora las barreras de adherencia, el impacto en la calidad de vida, o las realidades prácticas de la vida diaria del paciente. Medical Affairs está más cerca de esta realidad que casi cualquier otra función, porque los MSLs escuchan regularmente de los clínicos cómo se comporta realmente un tratamiento para pacientes reales — no solo para la población idealizada incluida en un ensayo pivotal.

De la pastilla a la salud

→ **Física**
→ **Mental**
→ **Social**
→ **Emocional**

El valor en salud, en este marco, es el resultado que el centrado en el paciente busca producir: no simplemente "¿funciona el fármaco?", sino "¿mejora el fármaco los resultados y la experiencia que más importan al paciente, entregados dentro de un sistema capaz de sostener esa mejora?". Precisamente por esto los resultados reportados por el paciente (PROs), las medidas de calidad de vida y la evidencia del mundo real se han vuelto centrales en los planes modernos de generación de

evidencia — son las herramientas que permiten a Medical Affairs medir realmente el valor en salud en lugar de asumirlo a partir de un endpoint subrogado.

- No "¿funciona el fármaco?" sino "¿mejora lo que importa al paciente?"
- PROs, calidad de vida y evidencia del mundo real — las herramientas para medirlo
- Miden el valor en salud real, no un endpoint subrogado

En concreto, el centrado en el paciente cambia la práctica de campo de un MSL en al menos tres sentidos. Primero, redefine qué cuenta como un insight médico valioso: la observación de un clínico sobre una barrera de adherencia, o un subgrupo que responde mal por razones que la ficha técnica no recoge, es exactamente tan importante como una pregunta científica puramente mecanicista. Segundo, justifica por qué Medical Affairs colabora cada vez más con grupos de defensa de pacientes y se relaciona, cuando es apropiado y conforme a normativa, con organizaciones de pacientes para entender la experiencia vivida directamente, y no solo a través del relato del clínico. Tercero, remodela cómo se establecen las prioridades de generación de evidencia: los estudios de evidencia del mundo real incorporan cada vez más endpoints reportados por el paciente junto a los clínicos, porque tanto pagadores como prescriptores esperan ya esa dimensión de prueba.

3 CAMBIOS EN EL DÍA A DÍA DEL MSL

1. **Redefine el insight valioso**
   Una barrera de adherencia pesa igual que una pregunta mecanicista
2. **Justifica la relación con pacientes**
   Colaborar con grupos de defensa, cuando es conforme a normativa
3. **Remodela la generación de evidencia**
   Los estudios RWE incorporan cada vez más endpoints del paciente

Para un MSL, mantener el centrado en el paciente genuinamente operativo — y no decorativo — significa preguntarse, en cada intercambio científico: ¿qué cambia realmente esta conversación para el paciente al otro extremo de la prescripción?

LA PREGUNTA QUE DEBES HACERTE

- ¿Qué cambia realmente esta conversación para el paciente al otro extremo de la prescripción?